

Propuesta de Implementación del Departamento de Medicina Integrativa

CEMIS — Centro de Medicina Integrativa Solidaria

Este documento propone la creación del primer departamento de Medicina Integrativa en el sistema SISOL, bajo la dirección de la Dra. Ximena Chirinos Orbegozo. El modelo articula la biología del conflicto (Germanische Heilkunde), las terapias sistémicas familiares y la medicina funcional como complemento al tratamiento alopático convencional, con el objetivo de mejorar los outcomes clínicos en pacientes con enfermedades crónicas.

Dra. Ximena Chirinos Orbegozo · CMP 36103

Médico Integrativa · Especialista en Nueva Medicina Germánica, Constelaciones Familiares y Medicina Funcional

Clínica Magga · La Molina, Lima

Lima, Perú · May 2026

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — USO EXCLUSIVO SISOL

Índice de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo
2. Contexto Epidemiológico y Necesidad Institucional
3. Marco Científico y Teórico
4. Los Tres Pilares del Departamento CEMIS
5. Modelo de Atención — Flujo Clínico Integrado
6. Objetivos Clínicos e Indicadores de Resultados
7. Propuesta de Nombre del Departamento
8. Perfil Profesional de la Directora Propuesta
9. Plan de Implementación — 3 Fases / 18 Meses
10. Estructura de Inversión y Proyección Financiera
11. Evidencia Internacional y Marco Regulatorio
12. Próximos Pasos y Solicitud Formal

1. Resumen Ejecutivo

El sistema de salud pública peruano enfrenta una paradoja estructural: disponemos de la infraestructura para atender el evento agudo —el infarto, el trauma, la fractura— con estándares comparables a los de cualquier país desarrollado. Sin embargo, más del **80% de la carga asistencial** recae sobre condiciones crónicas cuyo manejo exclusivamente farmacológico resulta, con frecuencia, insuficiente para modificar el curso natural de la enfermedad.

La presente propuesta plantea la creación del **Centro de Medicina Integrativa Solidaria (CEMIS)** en el Hospital de la Solidaridad, dentro de la estructura orgánica del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL). El CEMIS no sustituye ninguna especialidad existente; actúa como un puente clínico que complementa el tratamiento convencional mediante tres pilares terapéuticos con sustento científico: la biología del conflicto (Germanische Heilkunde), las terapias sistémicas familiares y la medicina funcional.

- **Modelo complementario:** El CEMIS opera en coordinación directa con cada especialista derivador, generando un ciclo de retroalimentación bidireccional que enriquece el diagnóstico y el seguimiento clínico.
- **Objetivos medibles:** Reducción del tiempo de enfermedad, disminución de la carga medicamentosa, menor tasa de rehospitalizaciones y mejora objetiva de la calidad de vida del paciente.
- **Escalabilidad:** El modelo piloto —diseñado para el Hospital de la Solidaridad— es replicable en cualquier sede SISOL, multiplicando el impacto sobre los 120 millones de consultas acumuladas en el sistema.
- **Evidencia internacional:** Brasil (PNPIC, 2006), la OMS (Estrategia de Medicina Tradicional y Complementaria 2019–2025), Cleveland Clinic, Johns Hopkins y Mayo Clinic cuentan con departamentos equivalentes integrados en su estructura institucional.
- **Viabilidad financiera:** La proyección a capacidad operativa plena (15 pacientes/día) genera S/ 36,000/mes en facturación, alcanzando el punto de equilibrio operativo con 8–9 atenciones diarias.

"SISOL transformó la visión de un médico cirujano en 54 hospitales y 120 millones de consultas. El CEMIS es la siguiente transformación: llevar medicina que sana desde la raíz a quienes más lo necesitan."

2. Contexto Epidemiológico y Necesidad Institucional

2.1 La Brecha en Salud Mental del Perú

El Perú presenta una de las brechas más amplias de América Latina entre la necesidad poblacional de atención en salud mental y la oferta asistencial disponible. Los datos del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud son elocuentes:

Indicador	Dato
Centros de Salud Mental Comunitarios faltantes a nivel nacional	384
Déficit solo en Lima Metropolitana	141
Peruanos con trastorno mental sin acceso a atención	> 70%
Nuevas sedes SISOL con psiquiatría (2025–2026)	El Agustino · La Victoria · Camaná · Wanchaq
Consultas acumuladas SISOL (histórico)	120 millones

SISOL ya ha reconocido esta necesidad y está respondiendo: la expansión de la psiquiatría en cuatro nuevas sedes durante el bienio 2025–2026 es una señal institucional inequívoca. El CEMIS se inscribe en esa misma dirección, ampliando la respuesta al componente psiconeurobiológico que la psiquiatría convencional no alcanza a cubrir en su totalidad.

2.2 La Limitación Estructural del Modelo Biomédico Clásico

El sistema médico moderno es extraordinariamente eficaz para la fase aguda de la enfermedad. El infarto se estabiliza, el tumor se reseca, la fractura se fija. No obstante, cuando el mismo paciente regresa —semanas, meses o años después— con la misma entidad nosológica o con comorbilidades nuevas, el modelo de una sola consulta, un diagnóstico y una prescripción se revela insuficiente.

La paradoja crónica	La oportunidad integrativa
• La medicación aumenta; la adherencia disminuye. • El órgano recibe tratamiento; la persona, no. • El paciente regresa. Y regresa. Y regresa. • El sistema se fragmenta entre especialidades.	• Identificar el conflicto biológico que originó el síntoma. • Incluir el sistema familiar en el mapa clínico. • Regulación del terreno para potenciar el tratamiento. • Retroalimentación bidireccional con el especialista.

Esta no es una crítica al sistema convencional — que es el pilar indiscutible de SISOL. Es la identificación de una brecha clínica real, resuelta con éxito en los sistemas de salud más avanzados del mundo mediante la integración de ambas medicinas.

3. Marco Científico y Teórico

El CEMIS se sustenta en disciplinas con creciente respaldo en la literatura médica indexada. No se trata de medicina alternativa: es ciencia publicada en revistas de primer nivel (PubMed, The Lancet, NEJM) que ha tardado en integrarse a la práctica clínica cotidiana por razones históricas y estructurales, no por falta de evidencia.

3.1 Psiconeuroinmunología (PNI)

La psiconeuroinmunología es la disciplina que estudia la interacción bidireccional entre el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmune. Sus hallazgos fundamentales demuestran que:

- El estado emocional del paciente modifica directamente la respuesta inmune, la producción hormonal y la actividad del sistema nervioso autónomo.
- El estrés crónico produce supresión inmunológica sostenida, aumentando la susceptibilidad a infecciones, enfermedades autoinmunes y neoplasias.
- La resolución del conflicto emocional se asocia con reactivación medible de la respuesta inmune en estudios prospectivos controlados.

3.2 El Eje Intestino–Cerebro–Psiquis

El microbioma intestinal es hoy reconocido como un órgano endocrino de primer orden. El 90% de la serotonina circulante es producida por las células enterocromafines del intestino, no por el sistema nervioso central. La evidencia establece que:

- La disbiosis intestinal correlaciona con depresión, ansiedad, fatiga crónica y enfermedades autoinmunes en múltiples estudios longitudinales.
- La inflamación sistémica de bajo grado —frecuentemente originada en el intestino— es un denominador común en la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles.
- Las intervenciones sobre la microbiota (dieta, probióticos, reducción de inflamación) producen mejoras clínicas documentadas en patología psiquiátrica y autoinmune.

3.3 La Germanische Heilkunde (Nueva Medicina Germánica) — Dr. Ryke Geerd Hamer

El Dr. Ryke Geerd Hamer (médico e investigador, Alemania) formuló las **5 Leyes Biológicas** a partir del estudio sistemático de más de 20,000 historias clínicas oncológicas y de otras especialidades. Su hipótesis central sostiene que toda enfermedad orgánica tiene una causa biológica identificable: un conflicto emocional inesperado, dramático y vivido en aislamiento (*Dirk Hamer Syndrome, DHS*) que impacta primero una región específica del cerebro y, desde ahí, el órgano correspondiente según el esquema embriológico del tejido.

1978

Su hijo Dirk muere de un disparo en el Mediterráneo. El Dr. Hamer permanece a su lado hasta el último momento.

1979	Le diagnostican cáncer testicular. Jamás había padecido enfermedad orgánica previa. La coincidencia temporal desencadenó el diagnóstico.
1981	Trabaja como médico en una clínica oncológica y estudia más de 20,000 casos. Identifica el mismo patrón en todos: conflicto emocional previo al diagnóstico.
Hallazgo	Enuncia las 5 Leyes Biológicas de la Germanische Heilkunde. Denomina el síndrome DHS (Dirk Hamer Syndrome) en honor al Dr. Dirk Hamer.

La Dra. Ximena Chirinos Orbegoza es especialista certificada en este método, lo que la posiciona como la profesional idónea para dirigir el departamento y garantizar la aplicación rigurosa y éticamente responsable de esta metodología en el contexto de la salud pública.

4. Los Tres Pilares del Departamento CEMIS

El modelo de atención del CEMIS se estructura sobre tres pilares complementarios que actúan de forma integrada, tanto en la evaluación diagnóstica como en el seguimiento terapéutico.

Pilar 1 — Biología del Conflicto (Método Hamer / Biodecodificación Clínica)

Objetivo clínico: Identificar el conflicto biológico de choque (DHS) que originó el síntoma orgánico. Comprender la lógica biológica detrás del síntoma, no solo suprimirlo.

Herramientas diagnósticas

- Anamnesis expandida con identificación del DHS
- Biodecodificación clínica del síntoma
- Trabajo sobre el 'modo pensar' del paciente
- Identificación de la raíz-causa de la enfermedad

Indicaciones principales

- Enfermedades autoinmunes
- Patología oncológica (rol complementario)
- Dermatología con componente emocional
- Neurología funcional
- Condiciones crónicas sin respuesta al tratamiento convencional

Pilar 2 — Terapias Sistémicas Familiares (Constelaciones / Terapia Sistémica)

Objetivo clínico: Ampliar la lectura diagnóstica al sistema familiar del paciente. Muchas enfermedades crónicas expresan conflictos no resueltos de generaciones anteriores; el abordaje sistémico permite intervenir en esa dimensión.

Herramientas terapéuticas

- Constelaciones familiares individuales y grupales
- Lectura del árbol genealógico como mapa de salud
- Terapia sistémica breve (individual)
- Trabajo con patrones de lealtad familiar

Fundamento clínico

- La enfermedad mejora cuando el sistema familiar mejora.
- Tratar solo al individuo sin entender su sistema es como apagar la alarma sin apagar el fuego.
- Indicado especialmente en cuadros crónico-recurrentes sin causa orgánica objetivable.

Pilar 3 — Medicina Funcional y Regulación del Terreno

Objetivo clínico: Optimizar el terreno biológico del paciente para que las intervenciones de los pilares anteriores —y el tratamiento alopático del especialista— alcancen su máxima eficacia terapéutica.

Herramientas de intervención

- Dieta antiinflamatoria personalizada
- Protocolo de regulación de microbiota intestinal
- Abordaje del eje intestino–cerebro–psiquis
- Reflexología podal
- Acupuntura (como complemento)

Principio rector

- No es posible resolver un conflicto emocional en un cuerpo inflamado.
- El terreno biológico determina si la enfermedad florece o se resuelve.
- La medicina funcional prepara el cuerpo para sanar — y optimiza la respuesta al tratamiento convencional.

5. Modelo de Atención — Flujo Clínico Integrado

El CEMIS opera como un nodo complementario dentro de la red asistencial de SISOL. No compite con ninguna especialidad: **dialoga con cada médico que trata al mismo paciente**. El flujo de atención está diseñado para generar valor en ambas direcciones:

	Consulta médica convencional	El especialista establece diagnóstico y tratamiento. Identifica candidatos a derivación (paciente crónico, polimedicado, baja adherencia, recidiva frecuente).
	Derivación al CEMIS	Criterios clínicos definidos en el protocolo interservicio. La derivación es voluntaria para el paciente y opcional para el médico.
	Evaluación Integrativa (90–120 min)	Anamnesis expandida: biología del conflicto, historia familiar, terreno funcional. Identificación del DHS y mapa sistémico.
	Protocolo personalizado + seguimiento coordinado	Sesiones individuales, talleres grupales (4–8 personas), ajuste dietético y funcional. Revisión quincenal de avance.
5	Retroalimentación al especialista	Informe clínico integrativo entregado al médico derivador. El especialista accede a la dimensión psiconeurobiológica del caso.

5.1 Criterios de Inclusión para Derivación

- Enfermedad crónica no transmisible con más de 6 meses de evolución y respuesta parcial o nula al tratamiento convencional.
- Polimedicación (3 o más fármacos crónicos) con baja adherencia documentada.
- Recidivas frecuentes (más de 3 episodios en 12 meses) de la misma patología.
- Paciente que refiere componente emocional o de estrés asociado al inicio o exacerbación del cuadro clínico.
- Solicitud expresa del paciente tras información sobre el modelo.
- Cuadros con componente funcional predominante sin correlato orgánico claro.

6. Objetivos Clínicos e Indicadores de Resultados

El CEMIS opera bajo un marco de evaluación de resultados basado en indicadores clínicos medibles desde el primer día de atención. La medición sistemática es condición indispensable para la credibilidad científica del modelo y para su escalabilidad institucional.

Dimensión	Objetivo	Indicador de Medición
Adherencia terapéutica	Mejorar el cumplimiento del tratamiento alopático prescrito	% adherencia reportado en revisión a 3 y 6 meses
Carga medicamentosa	Reducir el número de fármacos crónicos activos	N.º de fármacos en receta al inicio vs. 12 meses
Tiempo de enfermedad	Disminuir la duración de los episodios agudos	Días de baja / días de crisis por periodo
Rehospitalizaciones	Reducir reingresos evitables por la misma causa	Tasa de reingreso a 30, 90 y 180 días
Calidad de vida	Mejora objetiva en escalas validadas	SF-36 o WHOQOL-BREF al inicio, 6 y 12 meses
Satisfacción del médico derivador	Utilidad percibida del informe integrativo	Encuesta estructurada al especialista cada trimestre
Morbilidad / mortalidad (largo plazo)	Impacto sobre la historia natural de la enfermedad	Análisis de cohorte a 18 meses vs. grupo control SISOL

Si el modelo reduce las rehospitalizaciones en tan solo un 10% en un sistema con 120 millones de consultas acumuladas, el impacto social —y el ahorro económico directo para SISOL— es transformador.

7. Propuesta de Nombre del Departamento

La denominación del departamento tiene valor estratégico: debe ser científicamente rigurosa, institucionalmente coherente con la marca SISOL y accesible para el paciente general. Se presentan seis opciones evaluadas según tres criterios: recordabilidad, coherencia institucional y precisión clínica.

Opción	Denominación	Acrónimo	Fortaleza principal
★ Recomendada	Centro de Medicina Integrativa Solidaria	CEMIS	Une la identidad SISOL con el concepto médico. Memorable y escalable.
2	Departamento de Salud Integral y Bienestar	DSIB	Lenguaje de salud pública clásico. Conservador y de fácil adopción.
3	Centro de Medicina Mente-Cuerpo-Familia	CMCF	Refleja los tres niveles del modelo. Comprensible para el paciente.
4	Unidad de Medicina Complementaria y Biológica	UMCB	Científico y preciso. Distancia explícitamente de 'medicina alternativa'.
5	Centro de Atención Integrativa SISOL	CAIS	Simple, institucional y replicable en todas las sedes.
6	Área de Medicina Funcional e Integrativa	AMFI	Alineado con la terminología internacional (Functional Medicine).

8. Perfil Profesional de la Directora Propuesta

"No es una terapeuta. Es una médico que practica medicina desde la raíz."

Nombre completo	Dra. Ximena Chirinos Orbegozo
Número de colegiatura	CMP 36103 — Colegiada y habilitada
Trayectoria principal	Más de 15 años en Medicina Ocupacional — disciplina sistémica, preventiva, centrada en entornos y co
Especialización 1	Nueva Medicina Germánica (Germanische Heilkunde) — Método del Dr. Ryke Geerd Hamer. Especialis
Especialización 2	Constelaciones Familiares y Terapia Sistémica Familiar.
Especialización 3	Medicina Funcional — microbiota, eje intestino-cerebro, medicina antiinflamatoria personalizada.
Centro de práctica	Clínica Magga · La Molina, Lima · clinicamagga.com

8.1 Por qué ella es la persona adecuada

La Dra. Chirinos ocupa una posición singular en el panorama médico peruano: está en la intersección exacta entre la medicina convencional y la integrativa. No rechaza ninguna de las dos — las articula. Tiene el título, la habilitación colegial, la experiencia clínica en entornos sistémicos (Medicina Ocupacional) y las certificaciones especializadas en cada uno de los tres pilares del CEMIS.

Eso es precisamente lo que este departamento necesita: una directora que hable los dos idiomas médicos con igual fluidez, que pueda establecer protocolos conjuntos con los especialistas alopáticos y que tenga la credibilidad institucional para representar al CEMIS ante SISOL, el MINSA y la comunidad médica peruana.

9. Plan de Implementación — 3 Fases / 18 Meses

El plan de implementación contempla tres fases secuenciales diseñadas para minimizar el riesgo institucional, maximizar el aprendizaje operativo y garantizar la calidad asistencial desde el primer día de atención.

Fase 1 — Fundación (Meses 0–3)

Diseño del Departamento

- Protocolos de derivación con cada especialidad
- Criterios de inclusión / exclusión de pacientes
- Ficha clínica integrativa (historia expandida)
- Indicadores de seguimiento y outcome

Instalación Física

- 2–3 consultorios en el Hospital de Salud Mental
- Adquisición de equipamiento básico
- Sistema de agendamiento integrado
- Selección y onboarding del personal de apoyo

Integración Institucional

- Presentación ante jefes de departamento
- Protocolo de comunicación médico-médico
- Capacitación básica del equipo SISOL sobre el modelo

Fase 2 — Lanzamiento (Meses 3–9)

Primera Cohorte de Pacientes

- 5–8 pacientes/día en etapa inicial
- Prioridad: crónicos complejos ya atendidos en SISOL
- Sesiones individuales (90 min) y grupales (4–8 personas)
- Revisión quincenal con los especialistas derivadores

Medición desde el Día 1

- Registro de outcomes: tiempo de enfermedad, medicación, calidad de vida
- Escala de satisfacción del paciente
- Feedback del médico derivador
- Comparativo con cohorte de control

Talleres Grupales

- Psicoeducación: biología del conflicto para pacientes
- Taller de dieta funcional y microbiota
- Taller sistémico-familiar (introductorio)
- Materiales accesibles para el público general

Fase 3 — Expansión y Evidencia (Meses 9–18)

Escala

- 12–15 pacientes/día a plena capacidad
- Extensión progresiva a otras sedes SISOL
- Formación de un segundo médico integrativo

Publicación de Resultados

- Sistematización de la data clínica (18 meses)
- Informe de resultados para SISOL y MINSA
- Posicionamiento como modelo de referencia nacional
- Artículo para revista médica peruana indexada

Alianzas Internacionales

- Conexión con redes de medicina integrativa en salud pública
- OPS/OMS: alineamiento con Estrategia de Medicina Tradicional y Complementaria 2019–2025
- Intercambio con Brasil (PNPIC) y Argentina (CASID)

10. Estructura de Inversión y Proyección Financiera

La inversión requerida para la implementación del CEMIS es notablemente contenida en comparación con el valor clínico y social que genera. El modelo está diseñado para alcanzar el punto de equilibrio operativo en la fase de lanzamiento, sin comprometer la calidad asistencial.

10.1 Estructura del Departamento

Ítem	Modalidad	Costo Estimado
Equipamiento inicial	Inversión única	S/ 15,000 – S/ 20,000
Coordinadora administrativa	Contrato mensual	S/ 1,800 – S/ 2,200/mes
Asistente clínica	Contrato mensual	S/ 1,500 – S/ 1,800/mes
Materiales y consumibles	Gasto operativo mensual	S/ 800/mes
Total costos operativos recurrentes		S/ 4,100 – S/ 4,800/mes

10.2 Compensación de la Directora del Departamento

Concepto	Detalle
Título institucional	Directora / Jefa del Departamento CEMIS
Remuneración base mensual	S/ 8,000 – S/ 10,000
Revenue share variable	15–20% sobre facturación mensual superior a S/ 25,000
Presupuesto de investigación	S/ 1,500/mes (publicaciones y congresos)
Revisión contractual	A los 6 meses según indicadores pactados

10.3 Proyección de Ingresos y Punto de Equilibrio

Escenario	Pacientes/día	Días/mes	Tarifa promedio	Facturación mensual
Punto de equilibrio	8–9	20	S/ 120	S/ 19,200 – S/ 21,600
Capacidad inicial (Fase 2)	10–12	20	S/ 120	S/ 24,000 – S/ 28,800
Capacidad plena (Fase 3)	15	20	S/ 120	S/ 36,000

El CEMIS alcanza su punto de equilibrio operativo con 8–9 pacientes/día, equivalente al 60% de la capacidad inicial de Fase 2. A capacidad plena genera un margen operativo estimado de **S/ 22,000–25,000/mes** antes de considerar el componente académico y de formación.

11. Evidencia Internacional y Marco Regulatorio

La medicina integrativa no es una tendencia emergente: es una política de salud pública consolidada en los sistemas sanitarios más eficientes del mundo. El CEMIS no inventa un modelo; adapta al contexto peruano lo que otros sistemas de salud ya practican con evidencia documentada.

Institución / País	Modalidad	Año de implementación	Referencia
Brasil — Sistema Único de Salud	Política Nacional de Prácticas Integrativas e Complementares (PNPIC)	2006	Ministerio de Salud de Brasil
OMS — Global	Estrategia de Medicina Tradicional y Complementaria 2019–2025	2019	WHO/HIS/TRM/19.1
Cleveland Clinic (EE.UU.)	Center for Integrative & Lifestyle Medicine	Activo	my.clevelandclinic.org
Johns Hopkins Medicine (EE.UU.)	Johns Hopkins Integrative Medicine & Digestive Center	Activo	hopkinsmedicine.org
Mayo Clinic (EE.UU.)	Complementary and Integrative Medicine Program	Activo	mayoclinic.org
Argentina — CASID	Cámara Argentina de Salud Integrativa y Disciplinas	2010	casid.com.ar
Perú — MINSA	R.M. N.º 724-2009/MINSA — Medicina Complementaria en EsSalud	2009	MINSA / EsSalud

De especial relevancia es el antecedente peruano: EsSalud cuenta desde 2009 con centros de medicina complementaria en funcionamiento regular. SISOL tiene la oportunidad de ampliar ese precedente con un modelo más completo, más integrado y con mayor capacidad de medición de resultados.

"Brasil integró las terapias complementarias en su sistema público de salud en 2006. La OMS publicó su Estrategia de Medicina Tradicional y Complementaria en 2019. Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo Clinic — todos tienen departamentos de medicina integrativa. No inventamos nada. Llevamos al Perú lo que el mundo ya practica."

12. Próximos Pasos y Solicitud Formal

La presente propuesta constituye el documento base para iniciar el proceso formal de creación del CEMIS. Se solicita respetuosamente al Dr. Luis Rubio Ramos, Presidente de SISOL, la evaluación de los siguientes pasos:

Paso 1 — Aprobación del concepto	Aprobación institucional del concepto de departamento de medicina integrativa como componente de la estrategia de salud pública de SISOL para el período 2025–2027.
Paso 2 — Reunión de diseño conjunto	Reunión técnica entre la Dra. Chirinos y el equipo directivo de SISOL para definir: espacio físico disponible, recursos humanos de apoyo, cronograma de implementación de Fase 1 y estructura legal de la dirección.
Paso 3 — Marco contractual	Definición de la estructura contractual de la Dirección del CEMIS: modalidad de vinculación, compensación, indicadores de desempeño y condiciones de la revisión semestral.
Paso 4 — Protocolo interservicio	Diseño participativo del protocolo de derivación con los jefes de servicio de las especialidades con mayor volumen de pacientes crónicos.
Paso 5 — Lanzamiento oficial	Comunicado institucional de apertura del CEMIS, orientado tanto al equipo médico interno como a los pacientes SISOL y a los medios de comunicación especializados en salud.

Usted llevó los hospitales a la calle.

Ahora llevemos la medicina completa a los hospitales.

Dr. Hamer transformó su pérdida en una nueva medicina.

SISOL transformó una visión en 54 hospitales y 120 millones de consultas.

Hoy proponemos la siguiente transformación:

medicina que sana desde la raíz.

Dra. Ximena Chirinos Orbegozo

CMP 36103

Médico Integrativa · Directora Propuesta CEMIS

Clínica Magga · La Molina, Lima

clinicamagga.com

Lima, Perú — 31 de May de 2026

Firma / Sello